

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ROSANA DE CACIA DE SOUZA ARTUR

IDADE: 39	PESO: 85	ALTURA: 157	PROFISSÃO: Contadora
SINTOMAS: <i>insônia (a partir 11) / cansaço / perna inchada</i>			
<i>Refluxo gástrico / dor muscular</i>			
QUEIXAS: <i>Cansaço</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Janefite 05 / Pregabalina / Glifage / Donaxan</i>			
<i>↑ PA / ↑ Peso rápido / ↑ glicemia</i>			
MÉDICO: <i>Dra Ludmilla / Associação Calinas (Pse)</i>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>2 anos que não faz</i>			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S		ALMOÇO: S	LANCHE: S JANTAR: S
HORA QUE DORME: <i>22:15</i>		HORA QUE ACORDA: <i>6:30</i>	
COCHILO () S ☒ N		DORME ACOMPANHADO: ☒ S ☒ N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: ☒ S () N		DORMEM NO QUARTO: () S () N	
PET NO QUARTO: () S ☒ N			
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>oral</i>		BANHEIRO/NOITE: <i>1x</i>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>normal</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>normal</i>	MALLAMPATI:	IAH: <i>16</i>	SPO2: <i>88%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>Tiroideite / esquecimento</i>			
CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA		(S) NEUROLÓGICA () OUTROS: <i>Torácica</i>	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☒ S () N		SPO2 C/ CPAP: <i>88%</i> PRESSÃO NO EXAME: <i>6cmH2O</i>	
<i>16/10/24 Avaliação</i>			
<i>P = 4-6 cmH2O</i>			
<i>24/10/24 P = 4-6 cmH2O / fixo: 6 cmH2O</i>			
<i>TAH = 3,0 e/h</i>			
<i>m. de uso: 6h34</i>		<i>Relata que ainda sente</i>	
<i>fuga: 4,2 l/m</i>		<i>incômodo c/ a máscara</i>	
<i>Natacha</i>			
<i>06/11 P = 4-6 cmH2O</i>			
<i>IAH = 2,2 e/h</i>			
<i>m. de uso: 6h30'</i>			
<i>fuga = 7,3 lpm</i>			
<i>Cansaço melhorou</i>			
<i>O engargalo melhorou</i>			
<i>durante o dia. fua</i>			
<i>25/11 P = 6cmH2O</i>			
<i>24 IAH = 2,1 e/h</i>			
<i>m. de uso: 6h</i>			
<i>fuga = 0,1 lpm - (11,5 perc.)</i>			
<i>fua</i>			

08/01 P = 6cmHg
25 IAH = 1.6 efa
M. de uso: 6h54'

oriento o uso e pl fazer
eridolix

P = 6,0 cmHg
IAH = 2.0 efa
M. de uso: 2m

(caim) por que esquece de ligar,
oriento colocar extensão.

Paciente: ROSANA DE CACIA DE SOUZA ARTUR (38 anos)
Convênio: Bradesco
Matrícula: 895932700035013

Relatorio medico.- CPAP

Paciente em tto de transtorno de ansiedade e depressão com queixas de sono não reparador . Tem aponeia leve (AIH 16 por hora) dessaturação leve por curto período e microdespertares pouco elevados = 10,6 por hora.

Fez titulação de CPAP com pressão de 6 cm de h20 com eliminação dos eventos respiratorios na segunda metade do sono.

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Nome: ROSANA DE CACIA DE SOUZA ARTUR
Data de Nascimento: 19-11-1984
IMC: 31,64
Sexo: Feminino
Data do exame: 20-06-2023

Peso: 78 kg
Altura: 1,57 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 20-06-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 455,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,0 e 184,5 minutos. O tempo total de sono foi de 359,0 min, eficiência de 78,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 56,4%; estágio N3: 21,3%; sono REM: 19,8%. O índice de despertares foi de 6,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 6,5/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 37 hipopnéias. A SpO2 média foi de 96% e a mínima de 88%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 75 - 106 bpm e NREM de 69 - 123 bpm.

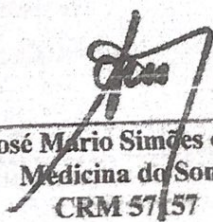
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (10,0/hora);
6. presença de atividade em EMG de queixo;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57